

THRESHOLD

THRESHOLD

**За восемь недель находит, какая еда
вызывает симптомы — по клиническому
протоколу.**

Первый протокол из библиотеки. Дальше —
сон, давление, нагрузка.

Живот реагирует на еду. На какую именно — непонятно

- Вздутие, спазмы, диарея или запор — часто через несколько часов после еды, иногда на следующий день. Виновника среди десятка съеденного не вычислить
- Похоже на синдром раздражённого кишечника — но для начала диагноз не нужен: протокол сам отвечает на вопрос, что вызывает симптомы
- Настоящая проблема — тревога перед едой: отменяют планы, избегают ресторанов и поездок, не зная, что сегодня безопасно есть
- Диета, которая действительно отвечает на вопрос, по клиническим рекомендациям требует подготовленного диетолога — а диетологов на эту аудиторию физически нет

Даже с диетологом до конца доходят четверо из десяти

- 41% доходят до шестой недели — с диетологом, но без ежедневного ведения
- Дело не в мотивации: никто не говорит человеку, какой сегодня день и что делать дальше
- Threshold ведёт день за днём — не хранит данные, а доводит до результата

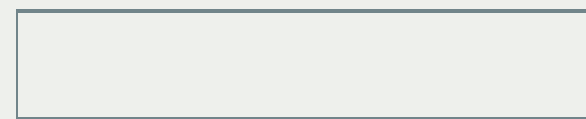
Не диагноз и не лечение. Протокол с доказательной базой

- Источник — опубликованный клинический гайдлайн, не наша гипотеза: ACG для питания, AASM/ACR для сна, NICE для тазового дна, AHA/ACC для давления
- Экран показывает наблюдения участника — что съедено, что изменилось. Диагноз и назначение остаются у врача
- У каждого шага есть источник, доза и срок перехода к следующему — гайдлайн, а не «попробуйте и посмотрите»
- Красные флаги останавливают протокол сам и без интерпретации ведут к врачу

Приложение знает, какой у вас сегодня день протокола

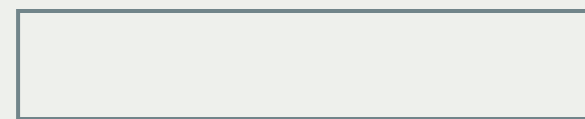
Сначала убираем продукты, которые чаще всего вызывают вздутие и боль — такие группы называют FODMAP. Через несколько недель возвращаем их по одному, маленькими порциями, и смотрим, что вызывает симптомы.

Базовая линия



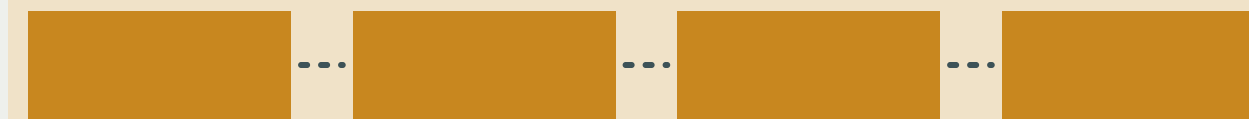
7–10 дней,
ничего не
убираем

Элиминация



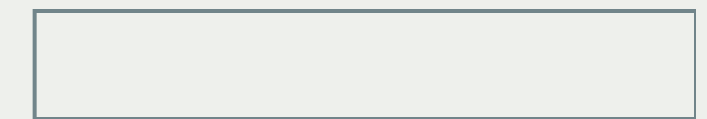
ведёт: что
убрано, чем
заменить

Реинтродукция



доза, окно, отмывка, решение

Карта



что переносится и в
каком количестве

- Четыре фазы с точными границами — система знает день 24 из 56 и что делать сегодня, то, что раньше мог сказать только диетолог
- Переход между фазами решает не самочувствие, а правило: доза, окно, число дней без симптомов
- Протокол честно закрывается выводом «не помогло», если за шесть недель ничего не изменилось — не тянется бесконечно и не продаёт гарантированный результат

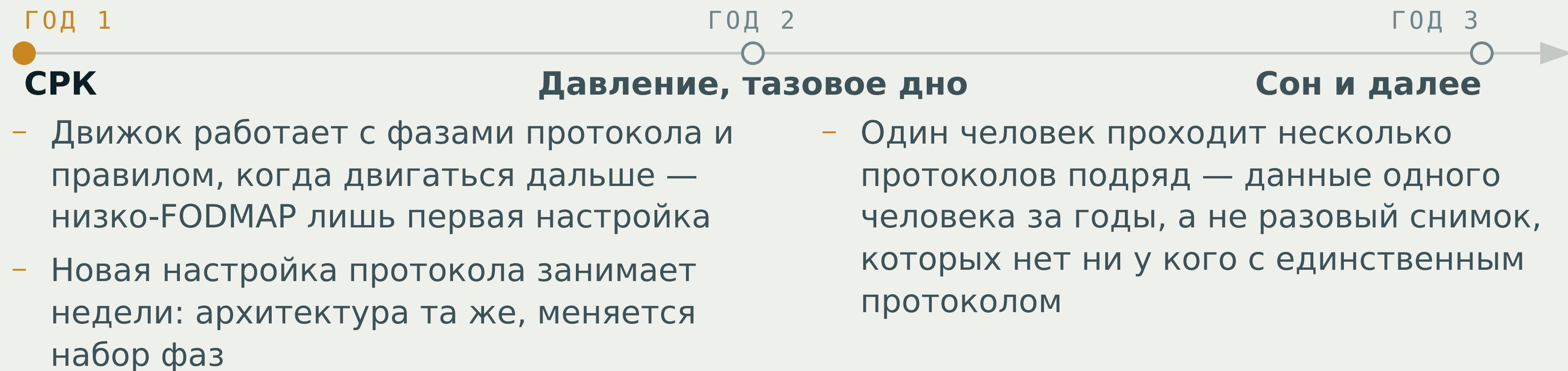
Два года назад это было нельзя построить. Через год позицию займут

- Разбор блюда на FODMAP-группы по фото — то, что раньше требовало диетолога, теперь стоит центы и секунду
- Голосовой ввод достаточно точен, чтобы отмечать симптомы, не открывая дневник — это и есть ведение со слайда 3
- Рынок уже принял ИИ-инструменты в здоровье — доверие создавать не нужно
- Технология доступна любому. Преимущество — в скорости сборки, не в эксклюзиве

Мы это уже построили. Сделаем снова — быстрее

- Команда несколько лет вместе. Система работает в клинике
- От данных с телефона до готовой выписки для врача — весь путь уже пройден один раз
- Движок настраивается под протокол, не переписывается заново под каждый
- Пересборка по подробному техническому описанию

Движок один — протоколов будет много



Инфраструктура для протоколов с участием специалиста — подбор врача, расписание, чат с пациентом — уже написана, вне объёма текущего этапа. Права — предмет отдельного разговора.

Протокол конечен. Продаём очередь протоколов, а не подписку

- Программа заканчивается результатом — картой переносимости и выпиской врачу, а не бесконечным приложением
- \$179 за программу, \$149 годовое поддержание карты, \$149 за каждый следующий протокол
- Ключевая метрика — не удержание в приложении, а доля перешедших ко второму протоколу: около 30%
- Позже — тариф с участием специалиста

THRESHOLD

\$179 приносит \$155 маржи. Дальше решает цена привлечения

\$155

МАРЖА С ПРОГРАММЫ

\$188—249

ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

\$150

ПОТОЛОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ

- Из \$179: \$12 себестоимость (93% валовой маржи), ещё около \$12 — резерв на возвраты. Остаётся \$155
- Пожизненная ценность одного пользователя — \$188–249, в зависимости от того, сколько доходит до конца
- Юнит-экономика положительна при цене привлечения до \$150. Комфортный запас — при \$75 и ниже
- Смоук-тест — единственный способ узнать, где мы окажемся

THRESHOLD

Инструменты для записи есть. Очередь никто не ведёт

ИЗМЕРЯЮТ	Function, Whoop, Oura — план, а не ведение
КУРС ИЛИ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	Nerva; Monash — Step 2, дозы, лесенка
ВЕДУТ	Salvo \$127/мес и Sleep Reset — на живых людях. Дороже и не масштабируется на новые протоколы
ПРОГРАММНО	только Stellar Sleep, один протокол
ПУСТО	несколько протоколов подряд в одной подписке — это Threshold

Не строим, пока не проверим, дешевле ли \$75-150 привести человека

- Лендинг с реальной оплатой: программа \$179 против подписки \$20/мес
- Порог зафиксирован до старта трафика
- 12 интервью проведены, страница готова
- Дальше: 8 недель сборки, октябрь — стенд с платящими

Три риска и механизм по каждому

РАССТРОЙСТВА
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В клинической когорте 23% с риском РПП, и приверженность диете у них **выше**, чем у остальных: 57% против 35%. Метрика роста и главный риск причинения вреда смотрят в одну сторону. Скрининг на входе, правило остановки внутри протокола, отказ обслуживать при срабатывании — в первой версии, не во второй

РЕГУЛЯТОРНЫЙ

Формулировки описывают, что мы видим, а не что лечим; разбор формулировок под FDA и FTC до включения трафика; юрист до релиза

ПЛАТЯТ ЛИ

Смоук-тест с порогом по стоимости привлечения до разработки

Данные и канал — не только выручка одного протокола

- Фарма с гастро-портфелем, консолидаторы цифровой терапии, потребительское здоровье — им нужны данные одного человека за годы по подгруппам и канал к пациентам, которых у них нет
- Библиотека протоколов превращает разовый продукт в датасет и канал — то, что не купить только ростом выручки одного протокола

THRESHOLD

\$165k, два этапа фиксированной ценой

- Смоук-тест — \$25 000. Ответ: дешевле ли \$75–150 привести платящего человека
- MVP — \$140 000, восемь недель. Работающий продукт и завершённый юридический пакет
- Фиксированная цена на оба этапа: результат оплачивается по факту сделанного
- Дальше — контракт на ведение с минимальным сроком, отдельно от этого запроса

Разбор Auyble: что построили, почему ушли к плательщикам

- Запуск DTC в 2022 году. Четыре фазы: Identification → Elimination → **Reintroduction** → Application; ML предлагает до 5 «подозреваемых» групп продуктов — единственный найденный конкурент с явной фазой реинтродукции внутри автоматизированного пути
- Цена при запуске — \$57.49–74.99/мес. Привлечено \$11.4М
- С 2025 года канал сменился на планы и работодателей: Priority Health (май 2025, 1.3 млн участников), Castlight (сентябрь 2025, доступ к Fortune 500)
- Ушла из прямого B2C именно тогда, когда стала глубокой — это главный эмпирический аргумент против B2C-only в этой нише, и получен он на компании, делавшей ровно то, что задумано здесь

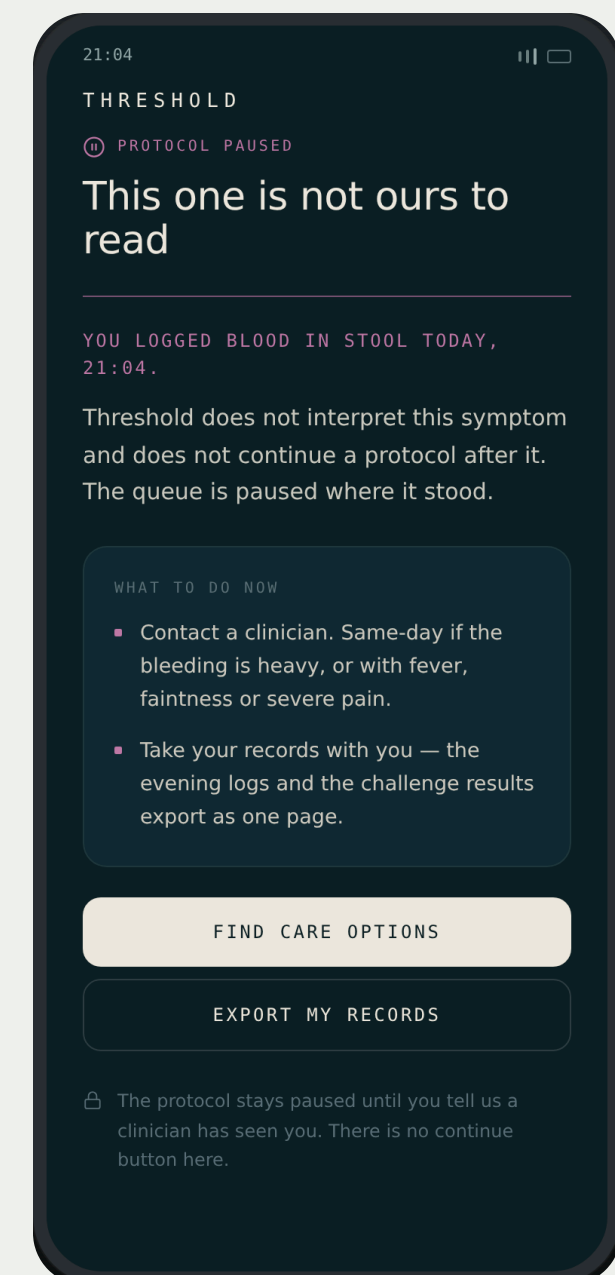
Разбор Nerva: 28 тыс. платящих, покупка активов Mahana

- Запуск июнь 2019. Шесть недель gut-directed гипнотерапии, ежедневно ~25 минут, затем поддерживающая фаза — уровень 1, протокол не ветвится
- 28 тыс. платящих подписчиков у Nerva, 31 тыс. по всем продуктам Mindset Health (Nerva, Evia, Finito — три отдельных подписки, не библиотека внутри одной). Привлечено \$18.7M, Series A \$12M при post-money \$52M (2023)
- 6 мая 2025 купила ключевые активы Mahana Therapeutics — компании с разрешением FDA (De Novo, затем 510(k)) и свыше \$80M привлечённых средств, обанкротившейся при этом разрешении на руках — и заявила, что встроит её CBT-контент в свою программу
- Единственный найденный игрок, устойчиво живущий на прямых потребительских деньгах в этой категории пять с лишним лет без венчурного дожигания роста; шестинедельная программа с «поддерживающей фазой» — прямое признание того, что после протокола удерживать нечем

Красные флаги и критерии исключения протокола

Протокол останавливается сам, если появляется что-то серьёзнее СРК: кровь в стуле, человек худеет без причины, симптомы будят по ночам, или всё это началось впервые после пятидесяти.

Экран не решает, что это значит, и не ставит диагноз — он останавливает очередь и отправляет к врачу.



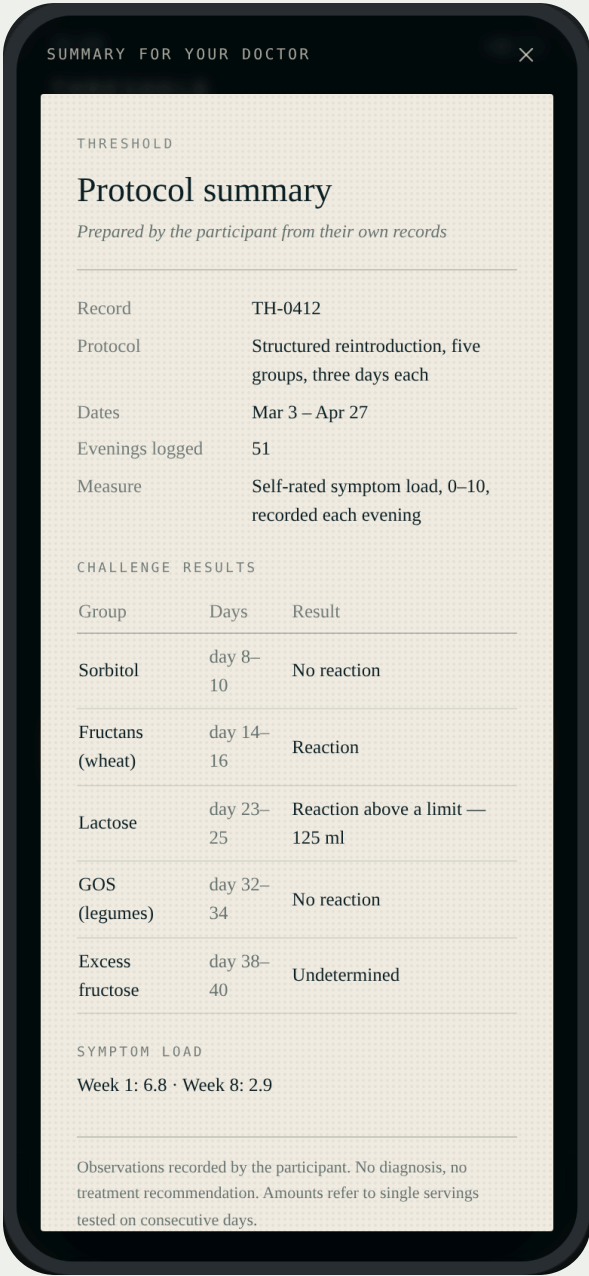
Следующие три протокола: источник гайдлайна, шкалы, длительность

- **Давление** — АНА/АСС 2025, схема «722»: два измерения подряд, дважды в день, семь дней. Шкал не требуется, протокол не под копирайтом. Риск заявлений: «управление давлением» звучит как лечение
- **Тазовое дно** — NICE NG210, супервизируемая программа 3–4 месяца с пересмотром. Кокрейн 2025 (41 исследование): датчик почти ничего не добавляет к тренировке без него. Шкала ICIQ лицензируется — в первой версии своя
- **Сон** — AASM/ACR, поведенческая терапия бессонницы: ограничение сна и стимул-контроль, 6–12 недель. Самая регулируемая из трёх — Somryst и SleepioRx уже получили клиренс FDA здесь. Шкала ISI — платная лицензия (Mari/ePROVIDE) — в первой версии своя

Экран прототипа с выпиской для врача

Одна страница: протокол, даты, результаты по группам продуктов и как менялось самочувствие — так же, как человек отмечал его сам каждый вечер.

Внизу — строка о том, что это наблюдения участника, не диагноз и не назначение.

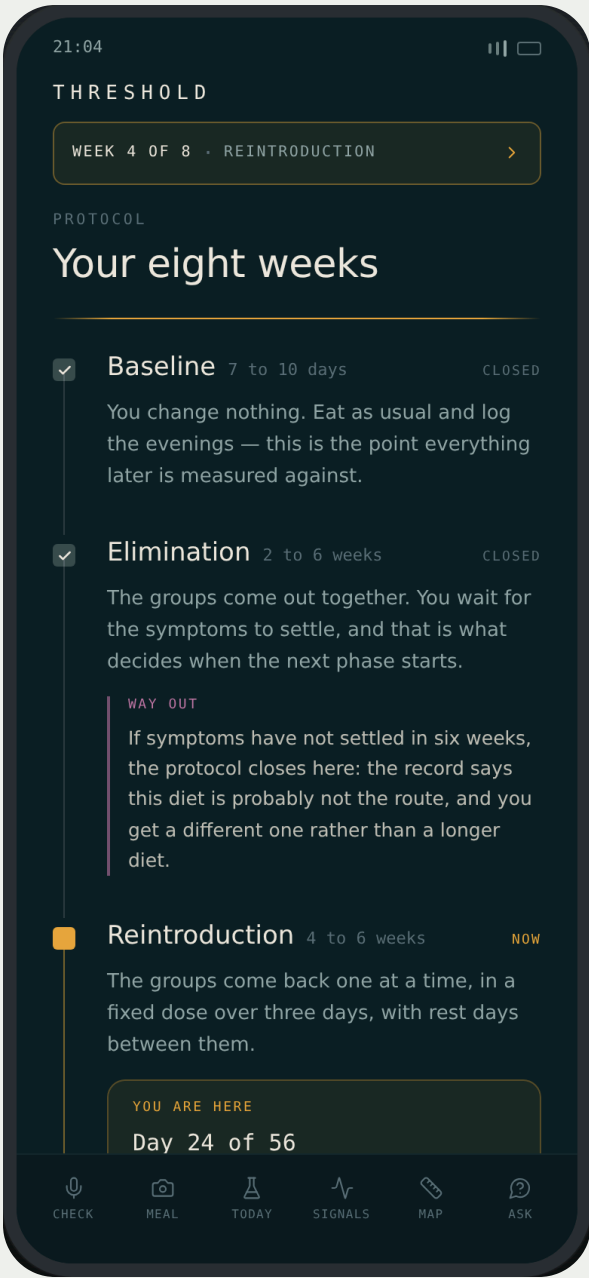


Экран прототипа: восемь недель протокола

Четыре этапа с понятными границами. Сейчас вы на дне 24 из 56.

Если за шесть недель ничего не изменилось, протокол сам скажет: эта диета, скорее всего, не ваш случай, и предложит попробовать другое — вместо того чтобы тянуть бесконечно.

Поэтому конец назван не датой, а окном в четыре-шесть недель: досрочно закрыть шаг раньше нельзя, симптомам нужно время осесть.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Экран прототипа: приложение ловит день, который бы всё запутал

Доза на сегодня и три дня подряд одна и та же еда — так проверяется одна группа продуктов, не смешиваясь с другими.

В эту ночь человек спал меньше пяти часов — а плохой сон сам по себе может вызвать те же симптомы, что и еда. Приложение это заметило и не засчитало день: иначе непонятно, из-за чего симптом. Предложено повторить.

